

CRISES HIPERTENSIVAS



ROTINA CLÍNICA

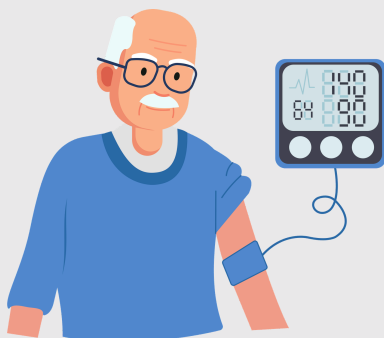
Material de apoio

Hipertensão arterial

- **Introdução:**

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença comum no Brasil, tendo prevalência de 32,5% nos adultos.

A elevação da pressão arterial (PA) é uma queixa comum de atendimentos em pronto-socorro, correspondendo de 3% a 25% das consultas, desde mau controle pressórico ambulatorial até, menos frequentemente, as emergências hipertensivas.



CRISE HIPERTENSIVA

- **As crises hipertensivas:**

1) Pseudocrise Hipertensiva;

2) Emergência Hipertensiva;

3) Pressão arterial muito elevada sem lesão de órgão-alvo (antiga “urgência hipertensiva”).



ROTINA CLÍNICA

PSEUDOCRISE HIPERTENSIVA

Definição:

Níveis pressóricos elevados associados a queixas de dor torácica atípica, dor osteomuscular aguda, estresse psicológico e síndrome do pânico.

Conduatas:

Deve-se buscar a causa base do aumento da PA e tratá-la, seja com repouso, analgésico ou tranquilizantes.

Evitar anti-hipertensivos.



ROTINA CLÍNICA

PA muito elevada sem lesão de órgão-alvo

Definição:

PA sistólica > 180 mmHg e/ou PA diastólica > 120 mmHg.

Sem lesão de órgão-alvo: avaliar a história clínica e o exame físico a fim de descartar!

Obs: corresponde à maioria dos casos de crise hipertensiva.



ROTINA CLÍNICA

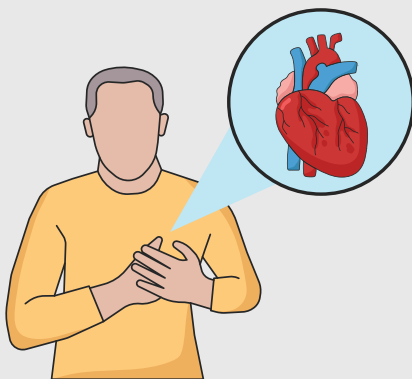
EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

Definição:

PA sistólica > 180 mmHg e/ou PA diastólica > 120 mmHg.

Com lesão de órgão-alvo aguda ou piora de lesão crônica de órgão-alvo.

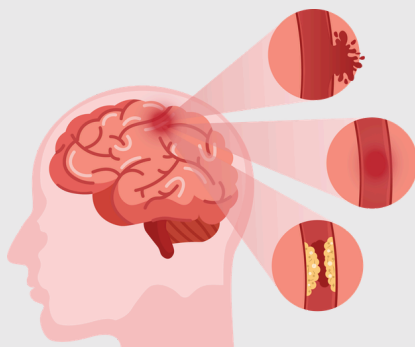
Obs: corresponde a cerca de 1% dos casos.



EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

Etiologias:

Encefalopatia hipertensiva;
Acidente vascular encefálico;
Síndrome coronariana aguda;
Edema agudo pulmonar;
Insuficiência renal aguda;
Crise adrenérgica;
Papiledema agudo.



DIFERENCIAÇÃO

Achados clínicos para diferenciar as duas possibilidades diagnósticas:

- Coletar informações sobre a PA usual do paciente;
- Averiguar HAS prévia e seu tratamento;
- Questionar quanto ao uso de substâncias que podem elevar a PA (drogas ilícitas, corticoide, AINES, álcool);
- Aferir a PA em ambos os membros superiores e realizar ausculta cardíaca;
- Avaliar aparelho respiratório (buscar sinais de congestão);
- Exame neurológico: buscar alteração de nível de consciência, déficit de força ou sensibilidade;
- USG de nervo óptico e fundoscopia**.



EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

Exames complementares:

Devem ser sempre solicitados de acordo com as suspeitas diagnósticas e sistemas (nervoso, respiratório, cardiovascular e renal).

- Hemograma completo; ureia e creatinina; eletrólitos e EAS.
- **Em suspeita de SCA e EAP:** ECG, radiografia de tórax, troponina e BNP.
- **Suspeita de AVE:** TC de crânio sem contraste.



EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

Os tratamentos são instituídos de acordo com o órgão-alvo acometido.

Resumidamente, objetiva-se realizar controle pressórico rigoroso e individualizado de acordo com a patologia.

Importante para o atendimento no cenário de ficha verde e amarela:

Encaminhar o paciente para a emergência, com monitorização multiparamétrica;

Realizar os exames complementares direcionados e disponíveis no serviço;

Entrar em contato com o serviço de referência de tratamento.



REFERÊNCIAS

- Medicina de Emergência FMUSP 17ª Edição – Emergências Hipertensivas.
- Avaliação e tratamento de emergências hipertensivas em adultos – UpToDate.
- Crises hipertensivas: definindo a gravidade e o tratamento - Revista SOCESP.

